



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

INFORME NEUROPSICOLÓGICO

Nombre: Dulcemaría Jimenez Mena
Documento de identidad: TI 1067615174
Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 2011
Edad: 12 años 4 meses
Colegio: Fisher School
Grado escolar: Sexto
Lateralidad manual: Derecha
Periodo de evaluación: 4, 10 y 11 de octubre de 2023

MOTIVO DE CONSULTA

Se realiza la valoración neuropsicológica de seguimiento, debido a los resultados observados en la evaluación realizada en 2022, en donde fue evidente una alta probabilidad que la paciente estuviera presentando un TDAH de tipo inatento, junto con dificultades significativas de tipo emocional y afectivo.

ANTECEDENTES DE DESARROLLO

Prenatales, Perinatales, Postnatales: Dulcemaría es adoptada, siendo la menor de dos hermanos (21 años, también adoptado). Su madre biológica es una familiar de su madre adoptiva, quien, dado que Dulcemaría fue producto de un embarazo no planeado ni deseado, decide darla en adopción. Dulcemaría sabe que es adoptada, pero hasta hace alrededor de dos años supo exactamente quien es su madre biológica, y a la fecha no ha manifestado interés en compartir con ella. No se reportan alteraciones prenatales. La paciente nace por cesárea, a las 34 semanas de gestación, con un peso de 2400grs (se desconoce la talla), con APGAR de 8-9-9. No se reportan dificultades postnatales, aunque estuvo en incubadora por varios días. Dulcemaría estuvo con su madre biológica hasta los 5 meses, luego fue adoptada.

Desarrollo psicomotor: A nivel de desarrollo, se reporta una adecuada adquisición de todas las habilidades de acuerdo con lo esperado. A nivel de motricidad gruesa, se reporta un desarrollo dentro de parámetros de normalidad, lo que le ha permitido aprender algunos deportes. A nivel de motricidad fina se reportan algunas dificultades para el aprendizaje de la escritura, aunque en la actualidad se evidencia una mejoría, tanto a nivel de productividad, como de velocidad y orden, adicionalmente, acaba de comenzar clases piano. En relación con el desarrollo del lenguaje, se reporta una adecuada intensidad comunicativa, con pronunciación de todos los fonemas; en relación con el aprendizaje del inglés se reportan dificultades, aparentemente relacionadas con el componente emocional y motivacional. No se reportan dificultades en el aprendizaje de control de esfínteres.

Familiar: Actualmente la paciente vive con sus padres (aunque su padre trabaja o en un pueblo cercano, de lunes a viernes). La relación con su hermano es buena, aunque el ya no vive en casa por sus estudios. Aunque en el pasado la relación con su madre estaba siendo bastante complicada,



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

gracias a algunos cambios en el manejo por parte de la madre, la relación ha mejorado, a tal punto que Dulcemaría ha mejorado mucho en su capacidad de expresión y gestión emocional.

Académico: A nivel académico, este año ingresó a bachillerato en una nueva institución, en donde su rendimiento ha estado dentro del promedio, pero las dificultades de tipo atencional, la participación y el componente emocional han afectado ligeramente su desempeño.

Médicos:

Personales: Vacunas contra Covid 19, 2 dosis, no se reportan efectos adversos. Covid 19 asintomático en 2020

Familiares: No reporta

Farmacológicos: Advil esporádico. Gotas de Valeriana

Traumáticos: Caída de los brazos de otra persona, a los 3 años, sin señales de contusión.

Quirúrgicos: No reporta

Convulsiones: No reporta

Patrón de sueño: Fluctuante.

Patrón de alimentación: Regulado.

Exámenes paraclínicos (EEG, RM, TAC u otros):

- **Evaluación neuropsicológica** en octubre de 2022: Alta probabilidad de TDAH. CI promedio bajo.

Componentes emocionales y comportamentales: De acuerdo con el reporte de la madre, en el último año se ha evidenciado mejoría a nivel del manejo emocional. La adaptación al colegio nuevo no presentó mayores dificultades, sin embargo, se reportan constantes verbalizaciones acerca de inseguridad (motivo por el cual no participa en clase); sin embargo, también están presentándose verbalizaciones positivas en relación con su capacidad de aprendizaje y mejoría.

OBSERVACIONES INFORMALES

Dulcemaría asiste a consulta en compañía de su familia, con una apariencia, porte y actitud adecuadas para su edad. Su talla y peso se encuentran dentro de la media; se evidencia un desarrollo adecuado.

Durante la valoración, se encuentra alerta, desarrollando las tareas propuestas de forma exitosa; en comparación con la evaluación previa, Dulcemaría se muestra mucho más abierta y colaboradora con el proceso.

PRUEBAS APLICADAS

- **Entrevista semiestructurada para padres:** por medio de la cual se abordan datos generales, motivo de consulta, historia de vida, antecedentes médicos relevantes, y se realizar una exploración inicial de la función cognitiva y comportamental del paciente.
- **Escala Wechsler de Inteligencia Para Niños, Niñas y Adolescentes Wisc – IV:** Test neuropsicológico dirigido a niños y adolescentes de edades comprendidas entre 6 años 0 meses y 16 años 11 meses. El test es aplicable preferentemente a grupos de sujetos de los que convenga determinar su nivel de destreza en habilidades cognitivas o funcionamiento neuropsicológico. Ampliamente utilizado para el cribado y diagnóstico de patologías del



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

neurodesarrollo y aprendizaje (altas capacidades; grados de discapacidad intelectual, dificultades del aprendizaje, disfunciones del neurodesarrollo y/o neuropsicológicas. En relación a la evaluación del TDAH, permite evaluar la calidad de la atención. Los índices de razonamiento perceptivo y de velocidad de procesamiento, son especialmente adecuados para ello.

- **Subpruebas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil – ENI 2:** batería neuropsicológica para niños, niñas y adolescentes, con edades entre los 5 y los 16 años. Comprende las siguientes secciones: atención, habilidades constructivas, memoria de codificación, habilidades perceptuales, memoria de evocación, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas.
- **Test de Atención D2:** Instrumento de evaluación de la atención, en donde se pueden obtener índices de velocidad de procesamiento y productividad, selectividad de la atención (omisiones y errores), y una relación entre la velocidad y la precisión de la ejecución
- **Sistema de evaluación de niños, niñas y adolescentes - SENA:** instrumento dirigido a la detección de un amplio espectro de problemas emocionales y de conducta desde los 3 hasta los 18 años. Incluye la evaluación de *problemas interiorizados* (componente emocional), *problemas exteriorizados* (TDAH y conducta), *problemas específicos*, e *índices de vulnerabilidad*.

RESULTADOS

Cociente Intelectual

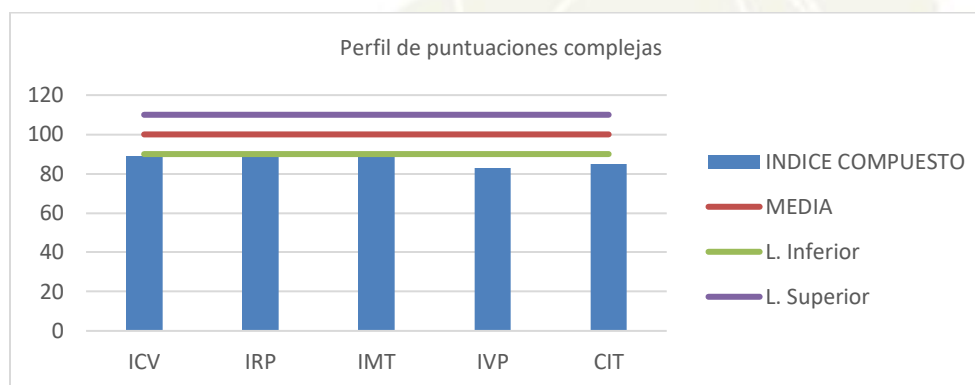
Subprueba	PD	Puntuaciones Escalares (10 +/-3)			
Diseño con cubos	18		5		
Semejanzas	23	9			
Retención de dígitos	14			8	
Conceptos con dibujos	19		10		
Claves	39				6
Vocabulario	34	8			
Secesión de números y letras	16			9	
Matrices	24		10		
Comprensión	21	7			
Búsqueda de símbolos	22				8
(Aritmética)	18			6	
		24	25	14	80
		CV	RP	MT	VP



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

	Suma de puntajes escalares	Índice compuesto	Rango percentil	Intervalo de confianza 90%
Comprensión Verbal	24	89	23	84-95
Razonamiento Perceptual	25	90	25	84-97
Memoria de Trabajo	17	91	27	85-98
Velocidad de Procesam.	14	83	13	78-83
ESCALA TOTAL	80	85	16	81-90



El Coeficiente Intelectual de 85 (un punto arriba que en la evaluación inicial) ubica el nivel de inteligencia de Dulcemaría en un nivel promedio bajo, en comparación con la media poblacional, lo cual indica que, aunque su nivel de inteligencia se encuentra dentro del promedio, algunas áreas requieren atención.

A nivel del *Índice de comprensión verbal* (90, 3 punto arriba del puntaje previo), que evalúa capacidades verbales utilizando razonamiento, comprensión y conceptualización, el puntaje se encuentra en el promedio, lo cual se relaciona con habilidades adecuadas en esta área, aunque se evidencian dificultades leves en la elaboración de un discurso complejo, para una pregunta abierta. Las habilidades de razonamiento verbal y conceptualización están dentro del promedio.

El *Índice de Razonamiento Perceptual* (90) se relaciona con habilidades de procesamiento de información no verbal, organización, percepción y razonamiento abstracto. Su resultado se encuentra dentro del promedio, lo cual indica habilidades desarrolladas adecuadamente. Es fundamental tener presente, que se presentó una disminución en el puntaje, pero está se debe al desempeño disminuido en el test diseño con cubos, lo cual es paradójico dado el buen desempeño en la evaluación previa; es posible que este resultado esté relacionado con el componente emocional.

El *Índice de Memoria de Trabajo* (91, 11 puntos arriba del resultado anterior) se relaciona con la capacidad para retener información por periodos cortos de tiempo, y trabajar con ella. Su resultado se encuentra dentro del promedio, lo que indica un desarrollo dentro de parámetros de normalidad en la actualidad.

Finalmente, el índice de *Velocidad de Procesamiento* (83) se encuentra en el promedio bajo; este índice media muchos procesos atencionales, y se relaciona con el nivel en la velocidad de procesamiento y de ejecución.



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

Lo anterior indica habilidades levemente disminuidas, que pueden interferir para desempeñarse de manera exitosa en cualquier ámbito académico regular, principalmente las relacionadas con atención y velocidad de procesamiento; las habilidades de lenguaje y memoria de trabajo mejoraron con el desarrollo.

Perfil Cognitivo

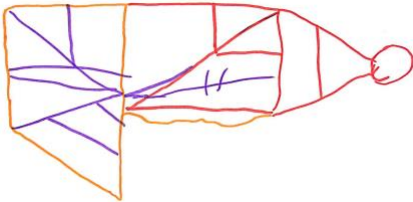
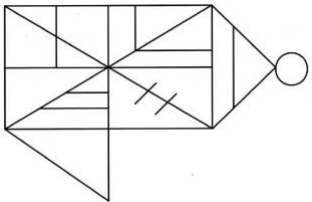
Atención

Atención	P. Directo	P. Escalar	Percentil	Interpretación
Claves - WISC IV	39	6		Bajo el promedio
Retención de dígitos – WISC IV	14	8		Promedio
Búsqueda de símbolos – WISC IV	22	8		Promedio
D2				
Total	158		2	Bajo el promedio
Índice Concentración	62		3	Bajo el promedio
Omisiones	5		60	Promedio
Errores	5		15	Bajo el promedio

A nivel atencional Dulcemaría posee la capacidad para mantener un estado de alerta y focalización de la atención apropiado, con un tiempo de sostenimiento de la atención adecuados para actividades cortas; sin embargo, cuando las actividades son extensas, su nivel de productividad baja significativamente, como se observa en el índice total y el índice de concentración del test D2. A nivel de la selectividad de la atención, se evidencian habilidades disminuidas para focalizar su atención en un estímulo, inhibiendo los demás estímulos tanto a nivel externo como interno, por lo que se presentan quiebres atencionales evidentes en el índice elevado de errores en el test D2. Las habilidades de alternancia y división de la atención se encuentran disminuidas, dado que son susceptibles a los fallos en sostenimiento y selectividad de la atención. Se evidencia una velocidad de procesamiento se encuentra disminuida.

Habilidades visuoconstruccionales y Praxias

Habilidades visuoconstruccionales - ENI	P. Directo	P. Escalar	Percentil	Interpretación
Diseño con cubos	18	5		Bajo el promedio
Copia de la Figura Compleja	12,5/15	9	37	Promedio



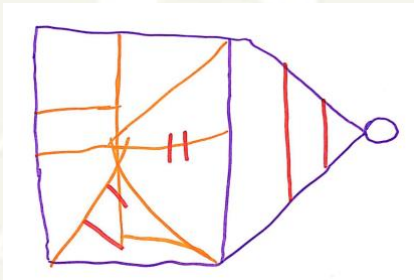
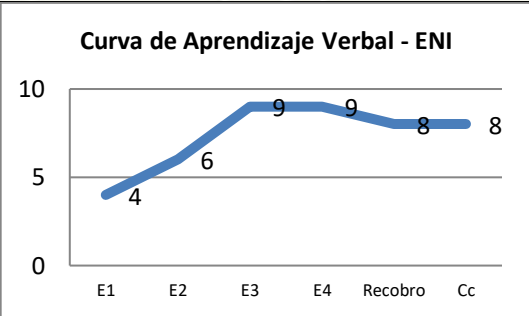


SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

Como se puede observar en el resultado de la copia de la Figura Compleja, Dulcemaría logra realizar una copia exitosa, similar al modelo, con habilidades adecuadas para integrar los diferentes elementos de la figura, aunque con fallos a nivel de planeación, precisión y atención al detalle (pero con un desempeño mejor que hace un año). Sus habilidades para la manipulación de objetos y la construcción de figuras determinadas con estos se encuentran dentro de parámetros de normalidad; es posible que el resultado disminuido en la prueba diseño con cubos, esté más relacionado con las dificultades emocionales y la baja velocidad de procesamiento, que con alteraciones praxicas, dado que en la evaluación previa el resultado estuvo dentro de parámetros de normalidad.

Memoria

Memoria - ENI				
	P. Directo	P. Escalar	Percentil	Interpretación
Recobro de la Figura Semicompleja	10,5/15	10	50	Promedio
				
Curva de Aprendizaje Verbal (Codificación)	28/48	16	7	Promedio bajo
Curva de Aprendizaje Verbal (Evocación Espontánea)	8/12	8	26	Promedio
Curva de Aprendizaje Verbal (Recobro por Claves)	8/12	8	26	Promedio
				

A nivel de memoria visual, se evidencian habilidades esperadas en la codificación de la información. A nivel del recobro, el resultado se encuentra dentro de parámetros de normalidad, lo que sugiere habilidades esperadas de almacenamiento y evocación de información visual.



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

En cuanto a la memoria verbal - auditiva, en la actualidad, el span atencional se encuentra dentro de parámetros de normalidad para su edad (5+/-2), presentando una curva de aprendizaje ascendente que se beneficia por las repeticiones, y que presenta un volumen de información codificada dentro del promedio. A largo plazo, se evoca espontáneamente la información codificada previamente, y aunque su desempeño no mejora con ayuda por claves semánticas, el volumen de información evocada ahora se encuentra dentro del promedio. Lo anterior indica habilidades normalizadas para codificación, almacenamiento y evocación de información verbal.

Habilidades Perceptuales y Gnósticas

Habilidades Perceptuales - ENI				
	P. Directo	P. Escalar	Percentil	Interpretación
Percepción Visual				
Imágenes Sobrepuestas	13/16	11	63	Promedio
Imágenes Borrosas	10/10	14	91	Sobre el promedio
Rec. Expresiones faciales	7/8	13	84	Promedio alto
Percepción auditiva				
Rec. Sonidos Ambientales	8/8	13	84	Promedio alto

A nivel de habilidades perceptuales, se puede observar que en general Dulcemaría posee un desempeño acorde con esperado para su edad; presenta habilidades esperadas identificar los componentes de un elemento bajo diferentes tipos de distorsiones. En relación con la habilidad para reconocer diferentes expresiones faciales y para relacionarlas con su correspondiente emoción, el resultado se incrementó significativamente, lo que indica una mejoría importante a nivel de inteligencia emocional.

En relación con percepción auditiva, está en capacidad de reconocer y nombrar la procedencia de diferentes sonidos ambientales.

Lenguaje y habilidades académicas

Lenguaje y habilidades académicas- ENI				
	P. Directo	P. Escalar	Percentil	Interpretación
Semejanzas				
Semejanzas	23	9		Promedio
Vocabulario				
Vocabulario	34	8		Promedio
Comprensión				
Comprensión	21	7		Promedio bajo
Repetición				
Palabras	8/8	11	63	Promedio
No palabras	8/8	12	75	Promedio
Oraciones	6/8	11	63	Promedio
Expresión				
Denominación de imágenes	14/15	13	85	Promedio alto



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

Comprensión				
Seguimiento de instrucciones	10/10	12	75	Promedio
Comprensión del discurso	6/8	11	63	Promedio
Lectura				
Precisión				
Lectura de palabras	11/11	10	50	Promedio
Lectura de no palabras	8/8	11	63	Promedio
Lectura de oraciones	8/10	7	16	Promedio bajo
Comprensión de oraciones	9/10	11	63	Promedio
Lectura en voz alta	6/8	11	63	Promedio
Lectura silenciosa	5/8	11	63	Promedio
Escritura				
Dictado de palabras	5/8	9	37	Promedio
Dictado de no palabras	8/8	14	91	Sobre el promedio
Dictado de oraciones	14/20	8	26	Promedio
Aritmética				
Manejo numérico				
Lectura de números	5/8	5	5	Bajo el promedio
Dictado de números	4/8	3	1	Bajo el promedio
Cálculo				
Aritmética	18	6		Bajo el promedio
Cálculo	7/12	6	9	Bajo el promedio

Dulcemaría presenta un lenguaje claro y coherente, acorde con el contexto, sin presencia de errores articulatorios.

El lenguaje automático y espontáneo se encuentra conservado.

A nivel de lenguaje expresivo, está en la capacidad de repetir, responder y formular sílabas, palabras, no palabras y oraciones según se le indique (y dado que hubo una mejoría a nivel de memoria de trabajo, su capacidad para almacenar a corto plazo información breve mejoró). Se evidencian una mejoría en la capacidad para elaborar un discurso en respuesta a una pregunta compleja, como se puede observar en la sección de lenguaje del WISC.

A nivel comprensivo, designa adecuadamente elementos que se le indican por vía verbal y sigue instrucciones simples y complejas apropiadamente. A nivel de la prueba de comprensión del discurso, se evidencia un resultado dentro del promedio.

En cuanto a procesos de escritura, presenta una caligrafía legible, con un nivel de ortografía dentro de la media, en comparación con lo esperado para su edad; su caligrafía ha mejorado así como el manejo del espacio, y la relación fonema grafema está establecida adecuadamente. A nivel de lectura, la relación grafema-fonema se encuentra establecida adecuadamente, con un nivel de comprensión adecuada para lectura en voz alta y lectura silenciosa.

A nivel de procesamiento aritmético, los resultados se encuentran disminuidos. Aunque ha mejorado levemente en la lectura y escritura de cantidades, los resultados no son acordes con lo esperado para su edad. En relación con la capacidad para realizar operaciones aritméticas, el



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

resultado es similar; se evidencia una mejoría en la capacidad de resolver problemas aritméticos y para realizar cálculos mentales, sin embargo, los resultados aún no entran dentro del promedio.

Funciones ejecutivas

Funciones Ejecutivas - ENI				
	P. Directo	P. Escalar	Percentil	Interpretación
Fluidez semántica frutas	12	9	37	Promedio
Fluidez semántica animales	18	10	50	Promedio
Fluidez fonémica	7	7	16	Promedio bajo
Conceptos con dibujos	19	10		Promedio
Matrices	24	10		Promedio
Números y letras	16	9		Promedio
Flexibilidad cognitiva				
Numero de ensayos	54/54	7	16	Promedio bajo
% Respuesta correctas	63	8	26	Promedio
% Errores	37	9	37	Promedio
Categorías completas	2	10	50	Promedio
Incap. Mantenimiento	1	5	5	Bajo el promedio
% Perseveraciones	7	13	84	Promedio alto

Finalmente, en cuanto a las funciones ejecutivas, se puede observar:

A nivel ventromedial presenta un desempeño adecuado, con la capacidad de mantener un estado alerta y motivación.

A nivel orbitofrontal, Dulcemaría se comporta acorde con el entorno, con habilidades optimas a nivel de inhibición conductual y para la comprensión y seguimiento de reglas sociales implícitas. En la evaluación previa se evidenciaron dificultades significativas a nivel de regulación emocional, lo cual afectaba directamente su desempeño; en la actualidad estas habilidades se han incrementado, lo que le ha permitido regularse efectivamente y no interfieren tanto con la ejecución de las diversas actividades.

Finalmente, a nivel dorsolateral, se evidencian habilidades adquiridas adecuadamente a nivel de razonamiento abstracto, categorización y flexibilidad cognitiva, con una mejoría significativa a nivel de memoria de trabajo, planeación y fluidez verbal. Las dificultades a nivel de control atencional se mantienen, lo cual es congruente con el diagnóstico.

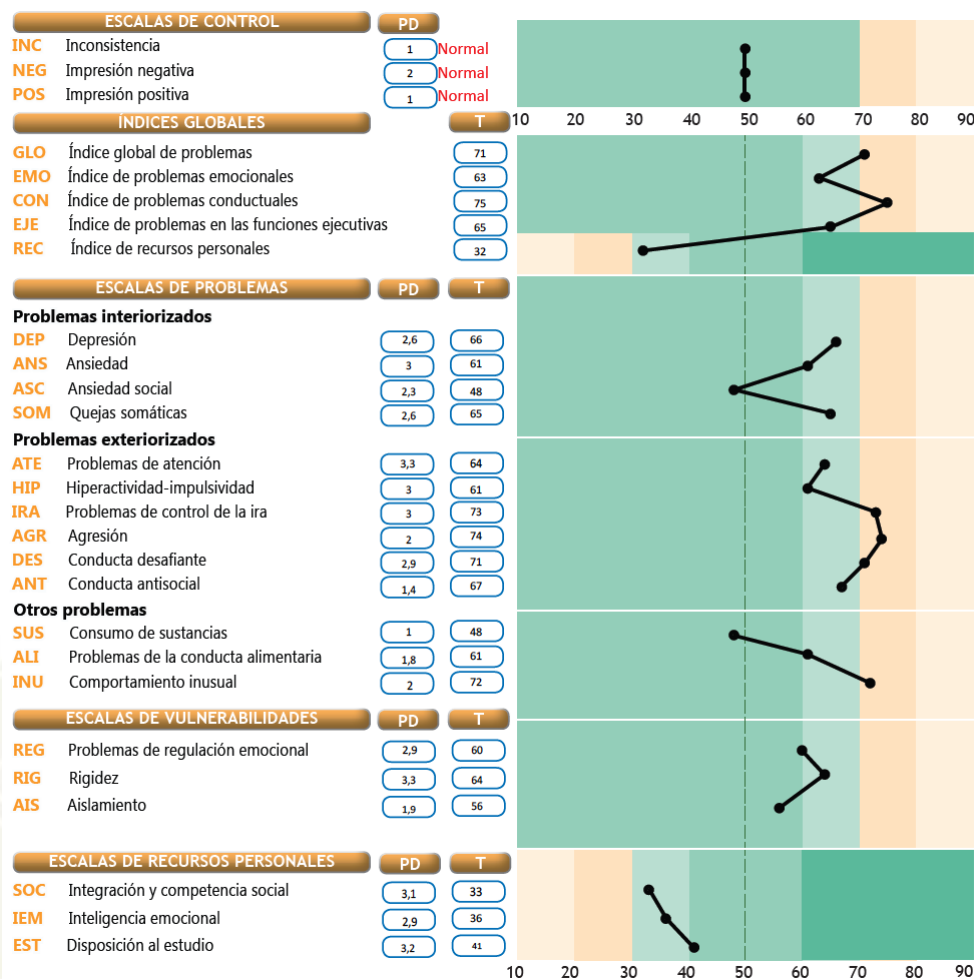


SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

Comportamiento, emoción y adaptación.

Sistema de Evaluación Niños, Niñas y Adolescentes - SENA - Familia



- **Escalas de control:** El cuestionario dirigido a la familia fue respondido por la madre y el padre. Se evidencia ausencia inconsistencia y de sesgos positivos o negativos. El protocolo es interpretable.
- **Examen de los índices globales:** El Índice global de los problemas (GLO), es una medida general de la prueba, que resume el nivel de afectación que la familia percibe que tiene la persona; en este caso, se obtuvo una puntuación elevada, lo que indica la presencia de dificultades, en las cuales se profundizará a continuación, **es fundamental tener presente que tanto en este, como en casi todas las escalas que se mencionaran a continuación, se evidencia una mejoría.** Se evidencia un puntaje promedio alto en el Índice de Problemas Emocionales (EMO), lo cual sugiere que las dificultades que está presentando la paciente, generan sufrimiento. Asimismo, se evidencia un puntaje alto en el Índice de Problemas Conductuales, lo que sugiere la presencia de comportamientos disruptivos, que generan problemas en casa y demás entornos en los que se desenvuelve. Adicionalmente, se evidencia un puntaje alto en el Índice de Problemas en las Funciones Ejecutivas (EJE), lo cual indica (y



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

reafirma), las alteraciones en el funcionamiento de áreas frontales, y es acorde con el diagnóstico de TDAH. Finalmente, se evidencia un puntaje promedio bajo en el Índice de Recursos Personales, el cual hace referencia a aquellas características de personalidad que puede ser protectoras o facilitar un tratamiento.

- **Interpretación de escalas de problemas:** En este apartado se pueden identificar las dificultades específicas que presenta la paciente en casa o durante las interacciones familiares. En el caso de Dulcemaría, en las escalas de *problemas interiorizados*, se reporta un puntaje promedio alto en la escala Depresión (DEP), lo cual indica la presencia de sintomatología depresiva leve, como por ejemplo un estado de ánimo disfórico, anhedonia y baja energía.

Asimismo, se reporta un puntaje en el límite entre el promedio y el promedio alto en la escala Ansiedad (ANS), lo que se puede evidenciar en nerviosismo, malestar subjetivo general, sobreactivación fisiológica y preocupaciones recurrentes o reacciones de aprensión/temor a determinador estímulos, situaciones o pensamientos. Adicionalmente, se reporta un puntaje promedio alto en la escala Quejas Somáticas (SOM), lo cual indica la presencia de malestar físico en ausencia de causas orgánicas, que podría estar asociado con el malestar emocional; este puntaje estaba dentro de parámetros de normalidad en la evaluación anterior.

En relación con los *Problemas Exteriorizados*, se reporta un puntaje promedio alto en las escalas Problemas de Atención (ATE) e Hiperactividad-Impulsividad (HIP), las cuales tienen como objetivo evaluar sintomatología relacionada con TDAH; esto indicaría dificultades a nivel de atención, inhibición conductual, control motor, toma de decisiones y regulación emocional; el resultado es acorde con la evaluación inicial, aunque disminuyó su nivel de gravedad, lo cual es positivo a nivel de adaptación. Adicionalmente, se reportan puntajes se evidencia un puntaje alto en la escala Problemas de control de la Ira (IRA), lo que indicaría experimentación y/o expresión exagerada e inapropiada del enojo o la ira, que se puede manifestar en comportamientos de tipo agresivo-impulsivo, sentimientos de rabia y/o en sensación de pérdida de control; este puntaje se incrementó levemente en comparación con la evaluación previa. Estos comportamientos pueden ser el resultado de una mayor presencia o intensidad de los sentimientos de ira o enfado, así como de dificultades para regular y expresar este tipo de emociones. La experiencia de la ira actúa en numerosas ocasiones como un disparador de agresión interpersonal, comportamientos de desafío o enfrentamiento a los padres y/o cuidadoras, o, en casos más graves, en conductas antisociales. Adicionalmente, se reporta un puntaje elevado en la escala Agresión (AGR), lo que indica la presencia de un patrón de agresiones contra otras personas; este resultado se correlaciona con el resultado en la escala control de la ira, pues sugiere que los comportamientos agresivos pueden ser el resultado de la pérdida del control en estados de alta emocionalidad, aunque es necesario tener en cuenta que disminuyó, lo cual indica un incremento en las habilidades de autorregulación. Finalmente, se evidencia un puntaje en el límite entre promedio alto y sobre el promedio en la escala Conducta Desafiante (DES), la cual evalúa comportamientos de desafío y de oposición a las figuras de autoridad. Incluye desde comportamientos más leves de desobediencia en el hogar y el colegio, hasta conductas que pueden reflejar una actitud hostil y de enfrentamiento claramente problemática. Los niveles elevados en esta escala pueden dificultar la socialización y la integración de la niña en el contexto social, familiar y/o escolar. Finalmente, se reporta un puntaje levemente elevado en la escala Conducta Antisocial (ANT), lo cual indica algunas dificultades para ajustarse a las normas y expectativas de la sociedad.



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

En último lugar, en relación con *Otros Problemas*, el resultado elevado en la escala Comportamiento Inusual (INU), indicaría la presencia de sintomatología de gravedad, frente a la que es necesario indagar desde psiquiatría, pero que podría estar relacionado con el diagnóstico de base, y además, presenta una mejoría. Adicionalmente, se reporta un puntaje promedio alto en la escala Problemas de la Conducta Alimentaria (ALI), que evalúa no solamente comportamientos atípicos en relación con la comida, sino además una pobre imagen corporal y pensamientos o verbalizaciones de desprecio al propio cuerpo (esta escala no estaba presente en el cuestionario anterior, por la edad).

- **Valoración de las escalas de vulnerabilidad:** Estas escalas indican puntos débiles o factores de riesgo, que, en conjunto con otras características, hacen más probable la aparición de problemas psicológicos. En el caso de Dulcemaría, se reporta un puntaje en el límite del promedio, en la escala Problemas de Regulación Emocional (REG), la cual indica que en la actualidad se han disminuido las dificultades para el manejo de sus emociones y su expresión, sin embargo, es fundamental continuar trabajando en este aspecto, para que esté en la capacidad de regularse a medida que aumentan las exigencias del entorno. Adicionalmente, se reporta un puntaje levemente elevado en la escala Rigidez (RIG), lo que indica la presencia de algunas dificultades a nivel de flexibilidad para enfrentarse a cambios en su rutina o dentro de su cotidianidad. Finalmente, el puntaje en la escala Aislamiento (AIS) entró dentro de parámetros de normalidad, lo que indica una mejor interacción con sus pares.
- **Análisis de las escalas de recursos personales:** Finalmente, las escalas de recursos personales indican las fortalezas que previenen que se desarrollen o incrementen problemas psicológicos, y que pueden contribuir con el tratamiento. Al respecto, mantiene un puntaje dentro del promedio bajo a nivel de Integración y Competencia Social (SOC), lo cual indica habilidades levemente disminuidas para iniciar y mantener relaciones de amistad, integrarse en grupos sociales y sentirse cómo en ellos, y en general relacionarse de forma adecuada con los demás. Adicionalmente, se evidencia una mejoría leve en la escala Inteligencia Emocional (IEM), lo que indica una mejoría en el reconocimiento de emociones, empatía, y la comprensión/expresión de diversos estados emocionales. Finalmente, en la actualidad, se reporta un puntaje dentro del promedio en la escala Disposición Para el Estudio (EST), lo cual refleja niveles adecuados de motivación para el estudio.

Conclusiones análisis SENA

Con base en los resultados obtenidos tras la interpretación de la escala respondida por la familia, y en comparación con los resultados de la evaluación anterior, se evidencia una mejoría general, lo cual indica que Dulcemaría se acerca a un nivel de ajuste. Aunque se mantienen indicadores de ansiedad y depresión, los puntajes disminuyeron, y junto con un aumento a nivel de inteligencia emocional, se evidencia que la paciente ha mejorado en sus habilidades de regulación emocional. A nivel comportamental, se evidencia también una mejoría, evidente en una disminución de la gravedad de los síntomas de TDAH, y de las conductas disruptivas que presentaba en el pasado.

CONCLUSIONES

- Con un CI de 85, el nivel de inteligencia de Dulcemaría se encuentra dentro del nivel promedio bajo, en comparación con la media poblacional, lo cual indica que presenta algunas dificultades



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

muy leves que pueden interferir con su desempeño (principalmente velocidad de procesamiento).

- Se evidencian habilidades desarrolladas dentro del promedio a nivel de habilidades visuoespaciales y visoconstruccionales, percepción, memoria visual y verbal, lenguaje y habilidades académicas (lectura y escritura).
- Se evidencian habilidades disminuidas a nivel de atención, habilidades académicas relacionadas aritmética, y las funciones ejecutivas (control atencional, memoria de trabajo, e inhibición conductual). Adicionalmente, se evidencia un resultado significativamente disminuido a nivel de velocidad de procesamiento.
- Los resultados del área cognitiva, confirman la alta probabilidad que la paciente esté presentando un **Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad TDAH, de tipo Inatento**.
- A nivel emocional y comportamental, con base en los resultados obtenidos tras la interpretación de la escala respondida por la familia, y en comparación con los resultados de la evaluación anterior, se evidencia una mejoría general, lo cual indica que Dulcemaría se acerca a un nivel de ajuste. Aunque se mantienen indicadores de ansiedad y depresión, los puntajes disminuyeron, y junto con un aumento a nivel de inteligencia emocional, se evidencia que la paciente ha mejorado en sus habilidades de regulación emocional. A nivel comportamental, se evidencia también una mejoría, evidente en una disminución de la gravedad de los síntomas de TDAH, y de las conductas disruptivas que presentaba en el pasado asociadas con el riesgo de TND (esto último está directamente asociado con los cambios que se han realizado en casa).

Recomendaciones

- Se recomienda que la paciente continúe con la intervención por psicología clínica orientado en continuar con el trabajo que se ha venido realizando en el componente emocional y afectivo, y en las estrategias de regulación emocional, de afrontamiento y tolerancia a la frustración. Finalmente, es fundamental que se refuerce autoestima, autoconcepto y autoeficacia personal.
- Por parte de neuropsicología, es necesario realizar un proceso de intervención, orientado a favorecer funciones cognitivas disminuidas. Una intervención por neurofeedback puede tener resultados favorables.
- A nivel académico, se recomienda que la paciente ingrese al programa de adaptación curricular, de acuerdo con los resultados de esta evaluación y con sus necesidades. Para estas adaptaciones, se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - Es fundamental hacer un seguimiento constante del estado emocional de Dulcemaría y e intervenir de manera oportuna cuando se evidencie alguna manifestación de desajuste. Estos indicadores pueden incluir inquietud motora, manifestaciones de tristeza, verbalizaciones negativas hacia si misma o hacia los demás, aislamiento, o conductas agresivas, entre otros. En caso que se evidencie, es fundamental apartarla de la situación, brindando contención emocional y desviando el foco atencional por unos minutos, de modo que pueda retomar sus actividades estando más regulada.



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

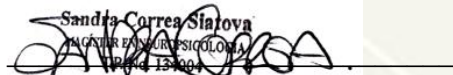
- La estudiante debe ser ubicada en la parte delantera del salón, retirada de puertas y ventanas. En casa, es importante que tenga un espacio destinado para realizar actividades de tipo académico, preferiblemente un escritorio, en donde tenga alcance los elementos necesarios, no esté cerca de distractores y esté cómoda.
- En áreas en las que presente dificultades, revisar de vez en cuando, a medida que está desarrollando la actividad, con el fin de garantizar que está entendiendo la lección o tarea, y además como estrategia de contingencia para que se mantenga el nivel atencional.
- Fomentar la participación en clase. Asimismo, motivar a Dulcemaría para que haga preguntas de lo que no haya entendido, o no sepa cómo realizar. Sin embargo, dado que la niña ha manifestado malestar frente a la presión de participar, se debe reforzar cuando lo haga, sin castigar cuando se abstenga de hacerlo.
- Entregarle a la estudiante un resumen o notas de lo trabajado, con el fin que tenga material adicional, en caso que se haya quedado atrasada, o esté presentando dificultad con algunos temas específicos.
- Establecer rutinas diarias y apegarse a ellas lo mejor posible. Dentro de las rutinas es necesario que esté establecido a qué hora se debe realizar cada actividad y cuánto tiempo se espera que le tome finalizarla, y esto se le debe comunicar a Dulcemaría, así como ir indicándole cuanto tiempo ha pasado y cuánto tiempo le queda.
- De ser posible, que el/la docente se ubique cerca de Dulcemaría. También, cuando no esté cerca y vea que la estudiante esté distraída, puede acercarse y usar una señal que llame su atención, como tocarle el hombro o poner una tarjeta de color sobre su escritorio, de modo que no se interrumpa la clase (esta señal debe ser acordada previamente con la estudiante). De usar esta estrategia en casa, lo más recomendable es que utilice la misma señal que en el colegio.
- Antes de iniciar un nuevo tema, anticiparle qué es lo que se va a aprender, de qué forma y cómo se espera que lo aplique.
- En la medida de las posibilidades, y sin que esto interfiera con el proceso de aprendizaje, darle pequeñas responsabilidades.
- Cuando la estudiante entregue actividades o evaluaciones, revisar si respondió todas las preguntas y en caso que haya faltantes porque las pasó por alto, darle tiempo para que termine. Otras opciones alternativas son calificar sobre lo entregado, darle más tiempo, o darle un menor número de ítems (pero garantizando que abarquen todos los temas, con un nivel de exigencia igual a de sus demás compañeros y compañeras). También se puede desarrollar una estrategia de evaluación no tradicional.
- No calificar orden ni pulcritud.
- Dar instrucciones en voz alta y por escrito. No permitir que inicie una actividad si no se ha terminado de dar la instrucción. Una vez el/la docente o cuidadores hayan dado la instrucción, pedirle a Dulcemaría que la repita, puede ser parafraseando. Esto con el fin de cerciorarse que escuchó y comprendió lo que debía hacer.
- Cuando las actividades sean largas, dividir las en pequeños proyectos, teniendo una lista de verificación de cada una de las actividades que debe realizar. Esta división la puede realizar la estudiante con apoyo de el/la docente.
- Hacer énfasis en que tenga sobre el escritorio únicamente lo necesario para realizar la actividad propuesta.



SANDRA CORREA SIATOVA

MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

- Realizar constante retroalimentación de los éxitos en el proceso. Dulcemaría puede beneficiarse de esto, pues va a ser consciente de su proceso, y buscará repetir las estrategias que le funcionen.
- Dentro de lo posible, es fundamental que se tenga una comunicación permanente entre padres y docentes, de modo que, semanal o quincenalmente, se les entregue un breve reporte de los éxitos de la semana o quincena, y las dificultades que haya presentado, para reforzar en casa.
- Utilizar como estrategia de regulación reforzadores no tangibles en lugar de castigos, de esta manera se incrementará la motivación.
- En caso que sea necesario llamar la atención, se debe hablar primero de lo que está haciendo bien, por ejemplo “hoy has estado trabajando muy concentrada, cantar puede distraerte y hacer que tardes más tiempo”. Asimismo, se debe hablar únicamente de la conducta inapropiada, evitando mencionar dificultades anteriores, o utilizar calificativos hacia la persona, por ejemplo “tu eres...”.
- Promover conductas de autorregulación, indicándole, cuando debe detener una conducta, cuando debe hacerlo un poco más rápido, o cuando es necesario que preste más atención. Por ejemplo, cuando está haciendo tareas, pero comienza a hablar, lo indicado sería decirle “ahorita me cuentas, primero termina esto”. Una vez finalice la actividad, se le pregunta qué quería decir. En caso que no se detenga, no se le debe responder hasta que finalice la actividad que está realizando.
- Finalmente, es importante que cualquier estrategia que se vaya a implementar, se le comente a Dulcemaría, no solo con el fin que esté enterada, sino que además pueda opinar sobre su proceso; preguntarle cómo se le puede ayudar puede facilitar la selección de estrategias para ella.


Sandra Correa Siatova
MAGÍSTER EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
TP. 134004

SANDRA CORREA SIATOVA

Magister en Neuropsicología Clínica

Especialista en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico TP. 134004